·药业专论·

药品上市决策中的多方利益博弈

康姗姗*，胡　霞，颜建周（中国药科大学国际医药商学院，南京市　210009）

中图分类号　F763；F714　　**文献标识码**　C　　**文章编号**　1001-0408（2010）21-1921-05

摘　要　目的：为政府处理好药品的社会属性和商业属性之间的关系提出建议。方法：通过建立博弈模型，研究药品上市决策中多方利益主体及相互关系。结果与结论：明确了医药产业的创新程度P、药品经营者的盈利率E、影响药品经营者收益的其他因素K、药品的额外镀金成本C_1、镀金药品的额外销售成本C_2等因素是影响药品生产企业进行药品上市决策的关键因素，并建议政府从加大政策倾斜、鼓励药品创新、对医疗机构销售药品实行差别加价率、优化医疗机构效益组成、鼓励临床合理用药、制定药品“上市价值”与“临床必需性”评价规范等方面保障人民合理、公平用药。

关键词　博弈分析；上市决策；科学监管；临床价值

Game Analysis on Muti-stakeholders in the Listing Decision of Drugs

KANG Shan-shan, HU Xia, YAN Jian-zhou（School of International Pharmaceutical Business, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China）

ABSTRACT　OBJECTIVE: To provide proposal for government on dealing with the relationship between commercial and social property of drugs. METHODS: Multi-stakeholders subjects and their interrelation in the listing decision of drugs were investigated using game model. RESULTS & CONCLUSIONS: Innovation level of pharmaceutical industry (P), profitability of drugs operator (E), other factors affecting the proceeds of drug operators (K), additional gold cost of drugs (C_1), additional cost of gold drugs sale (C_2) were confirmed to be the key factors which affected the listing decision of drugs by pharmaceutical manufacturers. Governments are suggested to ensure the rational and fair use of drugs in public by policy supports, encouraging drug innovation and make-up on difference of drugs in medical institutions, optimizing benefit components of medical institutions, creating evaluation criteria for “listing value” and “necessity in clinic” of drugs.

KEY WORDS　Game analysis; List decision; Scientific supervision; Clinic value

目前，我国药品市场中存在的问题仍然十分突出，一方面政府不断下调药品价格，另一方面降价药品很快从市场消失，群众没有得到实惠。出现这样情况的根本原因在于相关部门过于强调药品的社会属性，忽视药品的商业属性。因此，相关职能部门要采取科学的措施处理好两者之间的关系。

药品上市决策涉及企业、政府、药品经营者、患者等多方主体，各方的利益相互影响，政府必须抓住影响决策结果的关键因素，才能有效地进行监管。而对于药品上市决策这种多方行为互动问题的解决，博弈论为我们提供了有力的理论工具。本文根据主要的影响因素设计一个博弈的框架，借助博弈模型的分析，研究并说明这些影响药品上市决策的因素及其作用关系。

1　药品上市决策中多方利益博弈框架设立

鉴于本文研究政府对药品上市决策的科学干预，故在博弈分析中药品生产者、药品经营者和患者为主要参与方，政府部门并不直接参与博弈过程。

1.1　构建博弈框架

第1步：假设药品市场中药品生产企业生产2大类共3种药品：类型1：不拥有知识产权的传统药（传统基础药、传统镀金药）；类型2：拥有知识产权的创新药。

第2步：药品生产企业决定如何将药品出售给药品经营者：以药品的临床价值所对应的“正常价格”出售；或在不改变药品临床价值的前提下对药品进行非实质性改造，实现对药品的“镀金”后以“非正常价格”出售。此处的药品经营者限定为医疗机构（包括直接与患者接触的医师、药师以及其他从业人员）。

第3步：由药品经营者决定是否经营该种药品。

第4步：由患者决定是否购买该种药品。

在这一博弈框架中：药品生产企业和药品经营者对药品的临床价值以及各自所得利益完全了解，但是药品生产企业在决策时不完全清楚医疗机构的策略选择，即医疗机构所作决策对于药品生产企业而言属于完全但不完美信息，药品生产企业所作决策对于医疗机构而言属于完全且完美信息[1,2]。

在医疗机构与患者之间，由于医疗机构对药品的临床价值完全了解，处于信息优势，患者对于药品的实际临床价值并不了解，处于信息劣势，因此患者不完全了解得益情况的信息为不完全信息博弈[1,2]。

1.2　假设条件

（1）博弈各方都是理性“经济人”，以自身利益最大化为目标。（2）博弈各方都完全了解自己和其他方在各种情况下所能采取的各种对策。（3）市场上的药品均为合格药品。（4）市场中仅存在传统基础药、传统镀金药与创新药3种类型。（5）传统药与创新药的适应证或功能主治相似，但是创新药在安全性、有

*讲师，硕士。研究方向：社会与管理药学。E-mail：fish7068@gmail.com

中国知网 https://www.cnki.net

效性、质量可控性等方面有显著提高，临床价值高，具有明显的临床治疗优势。(6)创新药品定价合理，购买创新药获得的效用高于购买传统药品所获得的效用。

1.3 建立博弈模型

令$P_{基}$表示传统基础药的含税出厂价格，$P_{镀}$表示传统镀金药的含税出厂价格，$P_{创}$表示创新药的含税出厂价格，$C_{基}$表示传统基础药的成本，$C_{镀}$表示传统镀金药的成本，$C_{创}$表示创新药的成本，E表示药品经营者盈利率，K表示影响药品经营者收益的其他因素，X_1表示消费者购买传统基础药品时获得的收益，X_2表示消费者购买传统镀金药品时获得的收益，X_3表示消费者购买创新药品时获得的收益。$P_{创}>P_{镀}>P_{基}$，$X_1\approx X_2$，$X_3>X_1$。由于$X_1\approx X_2$，$P_{镀}>P_{基}$，因此患者每增加购买1单位传统基础药获得的收益要高于传统镀金药，而上文已假设购买创新药获得的效用高于购买传统药品所获得的效用，因此$X_3-P_{创}(1+E)>X_1-P_{基}(1+E)>X_2-P_{镀}(1+E)$。

第1阶段：药品行业中药品生产企业的创新情况。药品生产企业选择生产传统药的概率为p，选择研发创新药的概率为(1－p)。

第2阶段：药品生产企业选择如何将药品出售给药品经营者。当企业生产创新药品时由于药品的临床价值显著高于传统药品，且创新药的$C_{创}$较高，因此企业必然会选择以高价将药品出售给医疗机构。若成功出售，企业获得的收益为$P_{创}-C_{创}$，若无法出售，则企业损失成本$C_{创}$。

当企业生产传统药品时有2种选择：一是在不显著改善药品临床价值的前提下对其进行非实质性改造，实现对药品的“镀金”并以与药品临床价值不符的高价出售，即生产传统镀金药品；二是选择生产传统基础药品，并以低价进行销售。当企业选择前者时，需要付出额外的镀金成本C_1；同时由于医疗机构对药品的临床价值完全了解，要使得医疗机构接受与药品临床价值不符的价格并最终将药品出售给患者需要花费额外的销售成本C_2。如果成功，销售企业的收益为$P_{镀}-C_{镀}-C_1-C_2$；如无法出售，则企业的损失为$C_{镀}+C_1$。当企业选择后者即生产传统基础药品时，如果成功售出，企业的收益为$P_{基}-C_{基}$；否则，企业损失成本$C_{基}$。此处$P_{镀}-C_{镀}-C_1-C_2>P_{基}-C_{基}$，即企业对药品进行改造后所获得的收益要大于不对药品进行改造的收益，二者收益的差异性正是促使药品生产企业对传统药品进行改造“镀金”的推动力。

第3阶段：药品经营者决定是否经营某类药品。当医疗机构决定不经营某类药品时的收益为零。当医疗机构决定经营创新药品时的收益为$E\cdot P_{创}+K_{创}$；当决定经营传统基础药品时的收益为$E\cdot P_{基}+K_{基}$；当其决定经营传统镀金药品时的收益为$E\cdot P_{镀}+K_{镀}$。

第4阶段：患者决定是否购买某类药品。当患者决定不购买时的收益为零。当患者决定购买创新药品时获得的收益为$X_3-P_{创}(1+E)$；当患者决定购买传统基础药时获得的收益为$X_1-P_{基}(1+E)$；当患者决定购买传统镀金药时获得的收益为$X_2-P_{镀}(1+E)$。由于$X_1\approx X_2$，$P_{镀}>P_{基}$，因此患者购买传统基础药获得的收益要高于传统镀金药，而购买创新药获得的效用高于购买传统药品所获得的效用，因此$X_3-P_{创}(1+E)>X_1-P_{基}(1+E)>X_2-P_{镀}(1+E)$。患者购买经药品生产企业改造“镀金”后的药品所获得的收益是最低的。

据此，可以得到药品上市决策中多方利益博弈分析的模型，如图1所示。

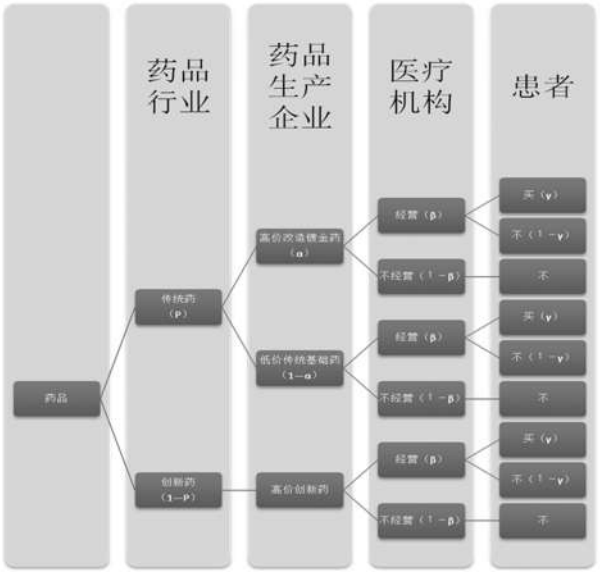


图1 药品上市决策中多方利益博弈模型

Fig 1 Game model of multi- stakeholders in the listing decision of drugs

2 博弈的分析过程——求解和讨论

假设药品生产企业选择对药品进行改造“镀金”然后再销售的概率为$\alpha(0\leqslant\alpha\leqslant1)$，则企业选择不对药品进行改造“镀金”直接生产销售传统基础药的概率为$1-\alpha$；假设药品中间商选择经营某种药品的概率为$\beta(0\leqslant\beta\leqslant1)$，则药品中间商不经营该类药品的概率为$1-\beta$；假设患者选择购买某种药品的概率为$\gamma(0\leqslant\gamma\leqslant1)$，则不购买的概率为$1-\gamma$。另外，分别以$\alpha^*$、$\beta^*$、$\gamma^*$表示该博弈的均衡解。

在药品使用行为模式中，患者(及其家属)在选择药品时面临着医疗诊断信息和药品使用信息的双重不对称，这种信息的不对称药品的使用权几乎均集中在医师这一方面[3]。因为当患者在医疗机构购买使用药品时医师拥有的医学知识和药学知识均高于患者，在药品的使用上医师在其医疗诊断的前提下所拥有的药品使用权也高于药师、护士、患者等人员，这些都在一定的程度上客观地造成了药品的使用垄断性。而这种药品使用权的垄断局面使得身为消费者的患者在选择消费药品时几乎没有自主选择权，因此在该博弈模型中，当药品经营者(医疗机构)选择经营某种药品时，患者几乎无法选择拒绝购买该药品，即患者选择购买某种药品的概率γ接近1，为方便计算，本文中假定$\gamma=1$。

2.1 计算博弈均衡解

2.1.1 设药品生产企业的期望收益为$M_{企业}$。

$$M_{企业}=p\{\alpha[\beta(P_{镀}-C_{镀}-C_1-C_2)+(1-\beta)(-C_{镀}-C_1)]+(1-\alpha)[\beta(P_{基}-C_{基})+(1-\beta)(-C_{基})]\}+(1-p)[\beta(P_{创}-C_{创})+(1-\beta)(-C_{创})]$$

当药品生产企业期望取得最大收益时，药品生产企业收益的一阶导数$\frac{\partial M_{企业}}{\partial\alpha}=0$，即：

$$\frac{\partial M_{企业}}{\partial\alpha}=p\beta(P_{镀}-C_{镀}-C_1-C_2)+p(1-\beta)(-C_{镀}-C_1)-p\beta(P_{基}-C_{基})+pC_{基}(1-\beta)=0$$

中国知网 https://www.cnki.net

化简可得：

$\beta(P_{镀}-C_2-P_{基})=C_{镀}+C_1-C_{基}$

得：

$$\beta^*=\frac{C_{镀}+C_1-C_{基}}{P_{镀}-C_2-P_{基}}$$

2.1.2 设药品经营者的收益为$M_{经营者}$。

$M_{经营者}=p\{\alpha[\beta(EP_{镀}+K_{镀})]+(1-\alpha)\beta(EP_{基}+K_{基})\}+(1-P)\beta(EP_{创}+K_{创})$

当药品经营者期望取得最大收益时，药品经营者收益的一阶导数$\frac{\partial M_{经营者}}{\partial \beta}=0$，即：

$$\frac{\partial M_{经营者}}{\partial \beta}=p\alpha(EP_{镀}+K_{镀})+p(1-\alpha)(EP_{基}+K_{基})+(1-p)(EP_{创}+K_{创})=0$$

化简可得：

$\alpha[p(EP_{镀}+K_{镀})-p(EP_{基}+K_{基})]=(p-1)(EP_{创}+K_{创})-p(EP_{基}+K_{基})$

得：

$$\alpha^*=\frac{(P-1)(EP_{创}+K_{创})-p(EP_{基}+K_{基})}{p(EP_{镀}-EP_{基}+K_{镀}-K_{基})}$$

2.1.3 设患者的收益为$M_{患者}$。

$M_{患者}=P\{\alpha\beta\gamma[X_2-P_{镀}(1+E)]+(1-\alpha)\beta\gamma[X_1-P_{基}(1+E)]\}+(1-P)\beta\gamma[X_3-P_{创}(1+E)]$

当$\gamma=1$时，

$M_{患者}=P\{\alpha\beta[X_2-P_{镀}(1+E)]+(1-\alpha)\beta[X_1-P_{基}(1+E)]\}+(1-P)\beta[X_3-P_{创}(1+E)]$

此时患者的收益完全取决于药品生产企业和药品经营者的策略选择，即患者的收益大小是由均衡解α^*、β^*决定的。

由“2.1.1”和“2.1.2”项可得上述博弈的均衡解为：

$$\alpha^*=\frac{(P-1)(EP_{创}+K_{创})-p(EP_{基}+K_{基})}{p(EP_{镀}-EP_{基}+K_{镀}-K_{基})}$$

$$\beta^*=\frac{C_{镀}+C_1-C_{基}}{P_{镀}-C_2-P_{基}}$$

$\gamma^*=1$

2.2 分析博弈均衡解

在给定的条件下，药品生产企业在进行药品上市决策时会以$(1-p)$的概率生产创新药物，p的概率生产传统药物，而在生产传统药物时企业会以α^*的概率选择对药品进行改造“镀金”然后再销售给药品经营者，而药品经营者会以β^*的概率选择经营某种药品。

同时α^*取决于社会的创新程度p、药品经营者的盈利率E、影响药品经营者收益的其他因素$K\{K_{创}、K_{基}、K_{镀}\}$、传统基础药的含税出厂价格$P_{基}$、传统镀金药的含税出厂价格$P_{镀}$以及表示创新药的含税出厂价格$P_{创}$；β^*取决于传统基础药的成本$C_{基}$、传统镀金药的成本$C_{镀}$、传统基础药的含税出厂价格$P_{基}$、传统镀金药的含税出厂价格$P_{镀}$、额外的镀金成本C_1、额外的销售成本C_2。

由于本文中已假设$P_{基}$、$P_{镀}$、$P_{创}$、$C_{基}$、$C_{镀}$是定量，这样影响均衡解α^*、β^*的因素为医药行业的创新程度p、药品经营者的盈利率E、影响药品经营者收益的其他因素$K\{K_{创}、K_{基}、K_{镀}\}$、额外的镀金成本C_1、额外的销售成本C_2。

3 政府科学干预药品上市决策的应对策略

基于上述分析，政府相关职能部门应采取适当措施处理好药品的社会属性和商业属性之间的关系，鼓励药品生产企业选择研发、生产那些既具备较高临床价值又能使人民在合理、公平条件下获得的药品。并在保障人民群众用药合法权益的同时又不至于过分强调药品的社会属性而压制了企业的积极性，通过科学监管促进医药行业的进步和发展。

3.1 加大政策倾斜，鼓励药品创新

为了改善医药行业的创新程度p，政府应当加大政策倾斜，鼓励药品创新。首先是资金问题。笔者认为政府应坚持贯彻重点扶植行业龙头企业的策略，使资源、资金高效地集中。目前，我国大大小小的医药企业有近6 000余家，布局混乱，竞争无序。这使得企业不得不增加广告营销的投入，在资金有限的前提下，对于风险高收效缓的药品创新项目往往表现得力不从心。政府可以通过建立财政性资金优先采购自主创新医药产品制度以加大政府的财政支持。有条件的地区可专门设立相关医药产业示范区，在园区内提供相对系统的优惠扶植政策以及专设相关的认证机构和咨询机构，为企业研发创新开绿灯，在履行好政府行政管理职能的同时，强调其服务的职能。积极鼓励企业与科技研发机构以及高校的合作，直接将科研转化为生产力；并通过设立和发展技术创业投资机构和产业投资基金，引导社会资金投向医药产业。其实风险投资的利用在成熟的资本市场运作中并非新鲜话题，美国的生物医药产业崛起的关键因素之一，就是风险投资机制以及基本市场的推动。但要使得该机制正常有效地运转以促进医药创新的发展，就要加强对投资机构和基金的监管。此外，《药品生产质量管理规范》(GMP)强制认证政策确实有利于提升我国药品生产水平，但同时也将大量宝贵的资金引入了医药产业最不需要的生产能力建设，高水平重复建设替代了以往的低水平重复建设，产能过剩，大量土地、厂房、设备处于闲置状态，资源极大浪费。笔者认为，政府部门可以通过鼓励企业之间的兼并重组或者在保证监管的前提下开放委托生产等方式来消化富余的产能，使闲置的固定资产变成流动的资金；另一方面，政府在GMP建设过程中，可以考虑结合药品生产企业的实际情况，对照标准，对目前的GMP进行调整，考虑分层次、分阶段建设，做到努力筹划、科学设计，把来之不易的资金用在刀刃上，让投入产生最大的效益。避免为了达到GMP认证要求产生“起步、标准要高，要一步到位”的想法[4]。这样企业将得以摆脱产能过剩的包袱，从而将更多的资源投入到新药的研发中去。

目前，政府的政策支持主要集中于创新药品的研发环节和生产环节，缺乏流通环节的政策支持。现行的药品定价机制就是制约药品创新的一大障碍。业内的权威人士纷纷指出目前这种以成本加成定价法，政府定价与企业定价相结合的做法，不能合理考虑药品的创新价值，对于鼓励企业的药品创新极为不利。以北京和凡医药科技公司的新药康容为例，该药历时6年时间，耗资400万元左右，实现了适应证方面的技术突破，于2003年拿到国家新药证书和药品生产批准文号，于同年6月获得国家发明专利。按照《关于单独定价药品价格制定有关问题的通知》的规定，申请单独定价，但结果物价部门仅根据药品成分含量加价30%，在厂家提出异议后，物价部门的解释很好地说明了新药定价的尴尬：知识产权、发明专利等不能作为新药定价的依据。这样的定价机制无疑极大地打击

中国知网 https://www.cnki.net

了医药企业对药品创新的积极性。目前的药品定价机制随着“医改”的深入也正处于变化之中，笔者认为在尽量保证老百姓“看得起病，吃得起药”的前提下，仍应兼顾医药企业的合理利润，建议相关部门能科学地提升创新药的创新价值在药品定价中的决定比例。同时，建议职能部门针对创新药品进入《医保目录》、参加药品招标采购等环节出台鼓励政策，让创新药品真正成为企业的利润源泉，提高企业研发新药的积极性。

3.2 对医疗机构销售药品实行差别加价率

针对药品经营者的盈利率E，政府应当加快实施对医疗机构销售药品实行差别加价率的步伐。按现行药品价格规定，药品在流通环节中，采取“顺价作价”原则，即规定医院可以加价15%“卖出”，获得的利润作为医院运营费用补偿[5]。在这种机制的影响下医疗机构逐步形成了对高价药的偏好，不利于医疗机构的合理用药。如果可以在药品销售中采用差别加价率，对于那些价格高但临床价值并没有明显优势的药品采用较低的加价率；对于性价比较高的廉价基础药品采用较高的加价率用以弥补因药价低给医疗机构带来的损失；对于价格较高的创新药品实行适中的加价率，在保证药品可获得性的同时维护医疗机构的合理利益。这样，对不同类型的药品实行差别加价率既可以引导医疗机构合理用药又可以在很大程度上保证患者和医疗机构双方的合法权益。

3.3 优化医疗机构收益组成，鼓励临床合理用药

药品收益以外影响药品经营者收益的其他因素K主要包括为患者提供医疗服务所获得的收益、政府投入部分和企业的寻租行为带来的“灰色收益”。针对因素K，政府部门应当优化医疗收益组成，增加前2项收益的比例，鼓励临床合理用药，以达到用市场手段科学干预药品生产企业药品上市决策的目的。

3.3.1 制定合理的医疗服务收费标准，弱化药品收益的重要性。在我国平均门诊费用和住院费用中，“药占比”近50%，检查和耗品占20%以上，而医务人员的劳动、技术、人才培养等劳务价值所形成的劳务收费仅占15%以下[5]。这种劳务付出与收益的严重失衡导致众多医院只能通过大量消耗药品来获取补偿。为此，在最近的“医改”方案中提出了进行药事服务费的试点。药事服务费是医师和医院在向患者提供诊疗服务时，加收的一项费用，也包括药品在用于患者前的运输储存等物耗成本。目前，日本、英国、加拿大等国家已经正式收取药事服务费，英国和加拿大是按处方量进行收费，而日本门诊和住院收费均包括了调剂费、处方费和附加费[6,7]。但作为一项全新的收费项目，在实施过程中需要在收费标准、实施细则等方面进行深入的研究与论证。

3.3.2 加大政府对传统基础药的补贴力度。事实上尽管传统基础药利润空间很小，但是借助政府的扶持，很多药品生产企业仍愿意生产。但很多医疗机构考虑到传统基础药的利润较低，往往不愿意采购该类药品。南京全市70家二级以上医院2006年第4季度的药品采购单中此类现象屡见不鲜，以阿司匹林肠溶片为例，价格昂贵的药品采购总量为廉价药品的2.24倍，订单金额的悬殊达到26倍[8]。

如果政府加大对医疗机构销售传统基础药的补贴力度，鼓励医疗机构销售价廉物美的传统基础药，那么该类药品的“生产-销售-使用”链将得以修复，患者的利益将得以保障。

3.4 制定药品“上市价值”与“临床必需性”评价规范

针对药品进行改造“镀金”所需的额外镀金成本C_1，药监部门应当制定科学合理的药品上市价值与临床必需性评价规范，进一步抬高新药审批门槛，限制传统镀金药品以“新药”身份获得药品单独定价。在现行的《药品注册管理办法》中，第47、65条已经抬高了新药的审批门槛。但是相关规定的表述仍存在难以确定的问题，例如在第47条、65条中均设立了除外条款即将“靶向制剂、缓释、控释制剂等特殊剂型”排除在受限范围以外，立法者的意图十分明显，即认可上述特殊剂型的优越性。然而事实果真如此吗？以缓释制剂为例，如果A药在正常的给药剂型下已经可以达到临床所需治疗效果，企业再将其改造成缓释制剂以新药的身份进行重新定价上市销售，那么采用这种方法“研制”出来的药品事实上并不是临床需要的，其临床必需性较差。现假设一种评价申报药品临床必需性的方式：

首先建立一个药品信息数据库，收录市场上药品的单位价格所创造的临床价值，然后将适应证相似的药品归为一类。如果某个药品提交注册申请，则将其单位价格所创造的临床价值同该类药品中单位价格临床必需性最高的替代药品相比较，其比值为此种药品的临床必需性(N)，具体如下式：

$$N=\frac{\dfrac{\text{单位申报药品的临床价值}}{\text{单位申报药品的预计价格}}}{\text{Max}\left\{\dfrac{\text{单位替代药品}S_1\text{的临床价值}}{\text{单位替代药品}S_1\text{的价格}},\dfrac{\text{单位替代药品}S_2\text{的临床价值}}{\text{单位替代药品}S_2\text{的价格}}\cdots\cdots\right\}}$$

(1)$0<N\leq1$时，申报药品的临床必需性较低。(2)$N\geq1+X$ ($X>0$)时，申报药品的临床必需性较高。(3)当X大于某一设定值时，该药品具有明显的临床应用优势。

当然，在这种评价方式中有关药品临床价值评定标准的确定、药品预计价格的测算以及市场中现有药品信息数据库的建立等一系列问题还有待相关专家学者的进一步研究。

3.5 打击医药商业贿赂，加强医德医风建设

药品生产企业在销售传统镀金药物时所耗费的额外销售成本C_2主要包括药品销售人员的激励措施和中间环节的寻租成本。政府应通过切实提高药品生产企业在销售环节的寻租成本，实现驱逐此类“镀金”药品的目的。政府相关政策法规的制定应有一定的系统性、科学性和可执行性。2008年11月20日最高人民法院和最高人民检察院联合印发了《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，其中明确规定：“医疗机构中的义务人员，利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品销售方财物，为医药产品销售谋取利益，数额较大的，依照刑法第163条的规定，以非国家工作人员受贿罪定罪处罚。”但由于医药行业的特殊性，我国在处方合理性的认定以及处方的审核制度等方面的相关规定仍然空白，此类案件在发现、定性、取证等方面比其他案件的难度更大，不确定因素也更多，因此目前增加医药从业人员的违法成本以限制寻租行为还很难收到预期的效果。政府部门应一方面积极组织专家就处方的合理性认定标准以及审核制度进行论证并出台细则，使得有效规范药品购销环节、增加相关医药从业人员的违法成本切实可行；另一方面应坚持加强医德医风建设，降低医药从业人员的道德风险。

参考文献

[1] 张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海：上海三联书店，

中国知网 https://www.cnki.net

·药事管理·

由一起行政诉讼案引发的对我国药品立法的再思考

邵　蓉[1,2*]，李奕璋[2]，蒋正华[1]（1.沈阳药科大学现代社会药学研究中心，沈阳市　110016；2.中国药科大学医药产业发展研究中心，南京市　210009）

中图分类号　R951　　**文献标识码**　C　　**文章编号**　1001-0408（2010）21-1925-03

摘　要　目的：为修订《药品管理法》中与药品定义以及非药品冒充药品有关的规定提供参考。方法：通过笔者亲自参与的一起行政诉讼案件的法律适用中遭遇的尴尬入手，分析存在的相关法律瑕疵。结果与结论：我国《药品管理法》中有关药品定义的规定不够精确、规范，且不利于将非药品冒充药品的情形界定为假药，应借鉴其他国家立法经验，在新一轮修订中予以完善。

关键词　药品定义；非药品冒充药品；法律适用

Reflection on Pharmaceutical Legislation in China from an Administrative Lawsuit Case

SHAO Rong, JIANG Zheng-hua (Research Center of Social Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China)

SHAO Rong, LI Yi-zhang (Research Center of Pharmaceutical Industry Development, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

ABSTRACT　OBJECTIVE: To provide reference for the revision of the concept of drugs and regulations on non-medical substance used as medicines that stated in *Drug Administration Law*. METHODS: The existing legal defects were analyzed according to the difficulty related to the application of law in a administrative lawsuit case. RESULTS & CONCLUSIONS: The conception of drug stated in *Drug Administration Law* is not accurate and standard enough, which is unfavorable to define non-medical substance used as medicines as sham medicine. *Drug Administration Law* should be improved by drawing lessons from legislative reference of foreign countries.

KEY WORDS　Concept of drugs; Non-medical substance used as medicines; Application of laws

笔者曾经接待过某法院的副院长和行政庭庭长、副庭长就正在审理的一起“非药品冒充药品”的行政诉讼案件涉及的产品定性和法律适用问题的登门咨询。本文就该行政诉讼案件法律适用中遭遇的尴尬，对我国现行《药品管理法》的有关药品定义的条款以及非药品冒充药品的法律适用存在的瑕疵进行分析，为新一轮修订予以完善提供参考。

1　案情简介

A市食品药品监督管理局在对某医疗机构执法检查中发现，该市B医药卫生用品厂（下简称B厂）生产的消毒用品碘伏（络合碘）说明书（标签）存在严重问题。例如，标签上注明：警示用语、药物组成、药理作用、适应症（证）、不良反应、药物的相互作用等栏目，其中警示用语为“请在药师指导下购买和使用”；药理作用栏下“对肝炎、爱滋病、疖肿等病毒、病菌及芽孢等具有强烈的杀灭作用”，以及“1分钟100%杀灭肝炎病毒”；适应症栏下“如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师”；批准文号为“国卫消字（2004）第0288号”，等等。A市药监局依照《药品管理法》第四十八条第三款（二）项“依照本法必须批准而未批准生产、进口的”的情形将“碘伏”按假药论处，然后依据《药品管理法》第七十四条对其进行了处罚。B厂不服，遂提起了行政诉讼，诉称其产品是消毒产品，不属于药监局管辖范围，请求法院判决撤销被告行政处罚决定书。

法院审理认为，本案焦点有2个：一是，B厂生产的“消字

2003：14～32.

[2] 谢识予.经济博弈论[M].第2版.上海：复旦大学出版社，2006：123～186.

[3] 王广平，冯国忠.试论医药流通领域的信息不对称现象[J].中国药业，2003，12(3)：26.

[4] 梁　毅.GSP认证六误[J].中国药店，2003，28(7)：60.

[5] 佚　名.公立医院药品15%“顺价加价”政策将取消[EB/OL].http://www.chinapharm.com.cn/html/hyyw/1231482-230156.html.2009-01-01.2009-06-25.

[6] 陈　文，胡善联，程晓明.发达国家药品价格和费用控制政策的比较研究[J].卫生经济研究，1997，12：40.

[7] 陈　文，胡善联，程晓明，等.药品的经济学探讨[J].中国卫生资源，1999，1：19.

[8] 陈向国.廉价药生存调查[J].中国卫生产业，2007，8：56.

*教授。研究方向：医药政策与法规。电话：025-86185188。E-mail：shaorong118@163.com

（收稿日期：2009-06-27　修回日期：2009-12-17）

中国知网 https://www.cnki.net